



3

58. ÅRGANG | 03 • 2021

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Tema

Artikler fra forskning
og praksis

PPT nr. 3-2021

Opsporing af psykisk vold mod børn

Af Mogens Nygaard Christoffersen

Opsporing af psykisk vold mod børn¹



Forskning i børnemishandling viser, at det er sparsomt med viden både begrebsligt, omfangsmæssigt og konkret i form af indsatser og metoder til arbejdet med børn udsat for psykisk vold af forældre eller stedforældre. Dette vanskeliggør opsporingen af børn udsat for psykisk vold på tværs af sektorer. Artiklen sætter fokus på operationelle definitioner med henblik på at kunne opgøre omfang, afgrænsning og opsporing af psykisk vold. Artiklen belyser desuden konsekvenserne af psykisk vold, og erfaringer med at ændre forældrenes destruktive adfærd, samt muligheden for, at social støtte fra andre end omsorgspersonerne kan mindske skadevirkningerne.

Mogens Nygaard Christoffersen, seniorforsker, emeritus

Min baggrund

Mogens Nygaard Christoffersen har beskæftiget sig med familiens demografi, daginstitutionens betydning for børns udvikling, sociale konsekvenser af alkoholmisbrug, personfarlig vold, børnemishandling, ADHD, vold og seksuelle overgreb imod børn, børn og unges selvmordsadfærd, selvskade og skolebørns angst.

Mogens Nygaard Christoffersen er magister i sociologi fra Københavns Universitet 1980. Startede med analysearbejde som student i 1971 og har lige siden været tilknyttet SFI/VIVE.

Indledning

The effects of psychological maltreatment has not yet been fully understood, and, according to Binggeli et al. (2001), the lack of consideration on is-

sues related to psychological maltreatment is one of the most significant reasons for the failure of child protective services.

Når forældre udsætter deres børn for psykisk vold, kan det have lige så vidtrækkende konsekvenser for barnet som fysisk vold eller seksuelle overgreb.

Der er al mulig grund til, at vi bør forholde os til psykisk vold som et skadeligt fænomen på linje med fysisk vold. Men hvor det primært har handlet om fysisk og psykisk vold imellem forældrene, vil det også være relevant at opholde os ved den psykiske vold, der rammer børnene.

Flere undersøgelser peger nemlig på, at for børn, der er udsat for forskellige former for vold og omsorgssvigt, er især den psykiske vold ødelæggende for barnets selvværd og evne til at klare sig videre i livet.

1 Baseret på kronik i Information, 9. februar 2019, samt foredrag den 6. maj 2019, "Overgrebsnetværkets" møde på Hotel Nyborg Strand. Rapporten 'Psykisk vold mod børn i hjemmet' indeholder en grundig gennemgang af forskningen (Ottosen, Frederiksen et al., 2020).

Hvordan kan man undersøge psykisk vold?

I den juridiske tankegang har man traditionelt ønsket at kunne adskille den bevidste handling, der skader barnet (mishandling), fra undladelseshandlinger (vanrøgt), der ikke har denne indbyggede hensigt. Men allerede i 1971 gjorde Newberger opmærksom på, at det essentielle element i børnemishandling ikke er *forældrenes intention* om at skade barnet, men snarere deres manglende kapacitet til at kunne udøve omsorg og empati for deres barn (Erickson, M. F. & Egeland, 2002; Newberger, 1972).

I forskningen af børnemishandling skelner man i dag mellem forskellige typer af mishandling udført af en omsorgsperson: fysisk mishandling, psykologisk mishandling, seksuelle overgreb og vanrøgt eller 'forsømmelse' (Cawson, Wattam, Brooker, & Kelly, 2000; Cawson, 2002; Myers et al., 2002).

Baggrunden for at differentiere de forskellige former for mishandling er, dels at man har fundet, at ætiologien (årsagerne) til forældrenes adfærd kan være meget forskellig inden for den enkelte mishandlingsform, dels at metoderne til at hjælpe forældrene til at ændre deres adfærd i nogle tilfælde kan være forskellige, afhængigt af hvilken form for mishandling, der er tale om (Busby, 1991; Christoffersen & DePanfilis, 2009).

Vanrøgt kan fx være udtryk for manglende kompetence hos forældrene på grund af overvældende belastninger. Den bagvedliggende årsag kan fx være en svær ubehandlet depression, alkohol-/stofmisbrug eller svag begavelse hos forælderen. Og en udredning

af årsagerne kan være en forudsætning for at kunne iværksætte relevante støtteforanstaltninger for at ændre forældredadfærden.

Barnets reaktioner på børnemishandling kan være mangeartede psykiske lidelser. Børnemishandling kan resultere i en depressiv og ulykkelig tilstand med frygt, angst, indlæringsproblemer og social isolation. Men barnets mentale problemer kan være forårsaget af mange forskellige forhold, hvoraf børnemishandling kan være en af årsagerne. Man må i hvert enkelt tilfælde indlede en nærmere undersøgelse for at kunne vurdere, om disse reaktioner hos børnene skyldes belastninger i deres nærmiljø eller helt andre forhold.

Formålet er at reducere omfanget af børnemishandling, dvs. finde årsager og metoder til at forebygge og ændre forældrenes uhensigtsmæssige adfærd. Ud fra dette formål har Binggeli og kolleger prøvet at bygge på nogle simple principper for udformningen af screeningsredskaber. For det første vil man opretholde en skelnen mellem de forskellige typer af børnemishandlinger og undgå en sammenblanding; dernæst har man tilstræbt at tage udgangspunkt i forældrenes handlinger – ikke deres intentioner eller hensigter (Binggeli, Hart, & Brassard, 2001).

Endelig har man ønsket at anvende de begreber og standardiserede målemetoder, som der er opnået enighed om for derved at kunne sammenligne undersøgelsesresultater og for at kunne drage fordele af tidligere forskningsresultater. Der skal være veldokumenterede grunde til at opfinde nye afgrænsninger og begreber, således at man kan overbevise andre forskere i

feltet om, at det vil være hensigtsmæssigt med ændringer af definitioner og afgrænsninger.

Fysisk mishandling

Fysisk mishandling er en handling, der resulterer i en fysisk skade eller risiko for en sådan fysisk skade (Kolko, 2002).

Børnelægerne beskrev i starten fænomenet som adskillige brud (Caffey's syndrom), som i nogle tilfælde optrådte sammen med blødninger i hjernehindrerne (subduralt hæmatom), idet man antog, at det var en særlig sygdom hos børn (fx knogleskørhed som følge af vitaminmangel eller andre sygdomme). Helt frem til begyndelsen af 1960'erne opererede man på skadestuen og hos lægerne ikke med den mulighed, at skader hos børn kunne være forårsaget af barnets forældre. Først i 1962 gav Kempe og kolleger en grundig og præcis beskrivelse af fysisk mishandling (battered child syndrome), sådan som det ser ud ved en hospitalsundersøgelse. Børnelægerne valgte at kalde fysisk børnemishandling for 'battered child syndrome' (Kempe, Silverman, Steele, Droegemueller, & Silver, 1962).

Forskerne gjorde dengang opmærksom på, at det hyppigt skete, at lægerne overså fænomenet. Det blev ofte ikke observeret, diagnosticeret og anmeldt til myndighederne, således at en gentagelse kunne forhindres. Det er desværre stadig et problem, viser flere undersøgelser. Hvis der er travlt på en skadestue, kan disse børn blive overset (King, Kiesel, & Simon, 2006; Ravichandiran et al., 2010).

Men risikoen for at overse en sygdom, der kan forklare de mange brud-

skader, og som dermed fejlagtigt kan føre til, at forældrene bliver anklaget for børnemishandling, er imidlertid også til stede. Det er derfor vigtigt, at børnene bliver undersøgt af en person med tilstrækkelig fagkyndighed, når mistanken melder sig (dvs. en børnelæge).

Principielt vil vi stå over for de samme afgrænsningsproblemer, når vi nu skal til at udrede, om der er tale om psykisk vold – eller som det hedder i fagjargon – psykologisk mishandling efter engelsk "psychological maltreatment" (Binggeli, Hart, & Brassard, 2001).

Psykisk vold

Psykologisk mishandling er et gentaget mønster, hvor barnet får at vide, at det er værdiløst, ikke elsket og uønsket (Binggeli et al., 2001; Brassard, Marla R. & Hart, 2000). Psykologisk mishandling indeholder to kategorier. Den ene er et systematisk mønster med forklejning, nedrakning, hvor barnet bliver gjort til syndebuk eller udsat for andre former for åbenlyst afvisende adfærd. Den anden kategori består af alle mulige trusler om mishandling, som fx at blive smidt ud hjemmefra, tæv eller trusler om seksuelle overgreb (Hamerman & Ludwig, 2000). Forældres adfærd kan iagttages over for børn i alle aldersgrupper – også overfor 0-2-årige. Eksempel på screenings spørgsmål stillet sundhedsplejerske om 2-årige om psykologisk mishandling (se tabel 1, i bilag).

Barnet kan i perioder blive holdt indespærret, eller blive truet med voldelig afstraffelse. Barnet kan også blive truet med tab af kærlighed eller af vig-

tige relationer. Barnet bliver måske tiltalt eller omtalt på en krænkende måde. For eksempel som ond/dum/grim/umulig eller et barn ingen kan lide. Forældrene kan forholde sig direkte fjendtligt til barnets behov. Barnet kan i perioder aktivt blive ignoreret af forældrene, som ikke vil høre barnet eller tale til det. Barnet kan blive forhindret i samvær med andre børn eller voksne. Forældrene viser deres manglende interesse for barnet ved at overlade barnet til at blive passet af et stort antal skiftende eller tilfældige voksne, eller til at blive passet af ikke-voksne større søskende (Christensen, 1992).

*Psykologisk mishandling*² er et gentagen mønster, hvor barnet får at vide, at det er værdiløst, ikke elsket, og uønsket (Brassard, M. R., Hart, & Hardy, 1991). Psykologisk mishandling er et vedholdende mønster af verbal mishandling og mobning fra forældre eller andre, der er i forældres rolle over for barnet, der kan være ødelæggende for barnets selvværd og sociale kompetence. Det vigtigt at erkende, at der er tale om et ulige magtforhold, hvor den, der udsættes for den psykologiske mishandling, er afhængig af omsorgspersonen, dvs. far, mor, stedforældre, større søskende mfl. Der skal være tale om en systematisk og vedvarende ydmygelse og nedgørelse, der resulterer i en undergravelse af barnets selvværd. Det ulige magtforhold indebærer, at barnet vanskeligt og ikke uden store omkostninger kan undvige volden.

2 Det internationale begreb "psychological maltreatment" (Binggeli, 2001) ser man tit oversat til dansk som "psykisk vold". I det følgende vil "psykisk vold" blive anvendt synonymt med "psykologisk mishandling" (Christoffersen, 2010).

Endelig foregår den psykiske vold ofte med tilhørere. En del af forklaringen på, at psykisk vold har den voldsomme effekt, er, at de krænkende og hånende udtalelser blandt andet går ud på at ydmyge barnet i andres øjne. Forælderen taler dårligt om barnet til andre. Ydmygelse og udskældning er en vigtig del af den psykologiske nedgøring (se tabel 2 i bilag). Barnet bliver ydmyget og truet på forskellig måde fx ved at blive smidt ud hjemmefra, eller direkte truet med vold. Barnet bliver konstant kritiseret og udsat for mobning, hvorved barnet får den opfattelse, at det er uønsket, ikke elsket og værdiløst (Christoffersen, Møhl et al. 2015).

Omfanget

Mange af begreberne diskuteres og udvikles stadig, og der kan være forskelligheder mellem definitionerne, som kan se ubetydelige ud – men som kan vise sig at have stor indflydelse på omfangsopgørelsen. Omfanget af psykisk vold vil afhænge af, om det er børnene selv, der interviewes som fx i skolens afgangsklasser eller 25-årige, eller om det er fagpersoner som fx sagsbehandlere (Christoffersen & DePanfilis, 2009), eller om det er sundhedsplejersker (Christensen, 1992), der interviewes.

I sundhedsplejerskeundersøgelsen finder man, at forældres psykisk vold imod spædbarnet omfatter 2 pct. af de 0-årige. I denne undersøgelse stilles 9 spørgsmål om psykisk vold, hvor blot et af spørgsmålene skal besvares bekræftende for, at det registreres som psykisk vold (tabel 1).

I en dansk undersøgelse skønnes (Christoffersen, 2002) psykisk vold at

optræde i omkring en tredjedel (36 pct.) af børnesagerne i lighed med udenlandske undersøgelser (tabel 3 og 4).

I undersøgelsen baseret på interview med 25-årige (Christoffersen, Møhl, DePanfilis, & Vammen, 2015) kræves en bekræftelse på mindst tre ud af de 6 spørgsmål om psykisk vold (tabel 2), fordi der i denne undersøgelse lægges vægt på at kunne opfange forældre eller omsorgspersoners systematiske mobning af børnene før man kan tale om psykologisk mishandling. Derved kommer man i denne undersøgelse frem til, at det er 5,3 pct. af børn, der oplever dette i barndommen (Vammen & Christoffersen, 2013).

Omfanget afhænger, hvor mange spørgsmål der indgår i indekset og selvfølgelig, om der er kontrolleret for spørgsmålenes validitet. Lad os tage et eksempel.

I et spørgeskema til sagsbehandlere blev stillet 12 spørgsmål om psykisk vold. Opdeles disse spørgsmål i to grupper (I og II) får man vidt forskellige opgørelser af omfanget hhv. 32 pct. og 18 pct. (se tabel 3 og 4).

Gruppe I indeholder 6 spørgsmål om forældre ydmyger barnet fx ved nedværdigende tiltale, ved omtale overfor andre eller ved offentlig ydmygelse af barnet (Christoffersen, 2002; Christoffersen & DePanfilis, 2010). Bliver barnet truet med at blive smidt ud hjemmefra eller truet med voldelig afstraffelse fx tæv eller pisk. Både de mindre børn og de større børns ønsker om hjælp og trøst kan blive ignoreret. Forældrene kan generelt være ude af stand til at vise omsorg for barnet (se tabel 3).

I den anden gruppe II stilles ligeledes 6 spørgsmål, som omhandler nogle andre kendetegn ved psykisk vold (se tabel 4). Forældrene viser gennem deres adfærd, at barnet er uønsket, ikke elsket og værdiløst. Forældre kan terrorisere barnet ved isolation ”taler ikke til barnet”. De voksne, som udgør barnets nærmeste netværk, mobber konsekvent barnet og kritiserer barnet. Forældrene kan fremkomme med trusler om at skade barnet eller om at overlade det til andre. Barnet kan blive overladt i farlige situationer. Barnet kan forbydes kontakt med jævnaldrende ved urimelige restriktioner på barnets bevægelsesfrihed (Christoffersen, 2002; Christoffersen & DePanfilis, 2010).

Der er en stort sammenfald mellem de børn og unge, der har været ude for psykologisk mishandling I og psykologisk mishandling II. Analysen af journaloptegnelserne viser, at 80 pct. af de børn og unge, der har været udsat for psykologisk mishandling II, har også været ude for psykologisk mishandling I (Christoffersen, 2002).

Kan psykisk vold gradbøjes?

Det kan antageligt i nogle sammenhænge være mest frugtbart at betragte psykisk vold som graddelt. Det betyder at opgørelser af omfanget er helt afhængige af, hvor man lægger skæringspunktet for, hvad der udgør grænsen for psykisk vold. Konstruktionen af indeks eller screeningsredskaber til brug for fx socialrådgivere og andre fagpersoner egner sig ikke til at angive præcist, hvor mange børn, der udsættes for fænomenet, men metoden kan bruges til at foretage *en sammenlig-*

nende analyse. Vi må på denne baggrund acceptere, at der kan være forskellige grader af psykologisk mishandling, og at det er vanskeligt præcist at angive, hvor grænsen går for, hvad der er skadeligt.

Længerevarende konsekvenser af psykisk vold mod børn

Nogle af de tidlige forskningserfaringer viste, at psykologisk mishandling kan have længerevarende konsekvenser. Forskerne fandt, at psykologisk mishandling³ er en af de mest signifikante prædiktorer for negativ udvikling og ser ud til at producere de mest destruktive effekter (Egeland & Erickson, 1987; Erickson, Martha Farrell & Egeland, 1987). Forskningserfaringerne tydede på, at psykologisk mishandling både kan have akutte og længerevarende konsekvenser. Et vedholdende mønster af verbal mishandling og mobning fra forældre eller andre, der er i forældres rolle over for barnet, viste sig at være ødelæggende for barnets selvværd og sociale kompetence (Garbarino, Guttman, & Seeley, 1987; Gross & Keller, 1992; Kuo, Goldin, Werner, Heimberg, & Gross, 2011; Mullen, Martin, Anderson, Romans, & Herbison, 1996). Man fandt sammen-

hænge mellem psykologisk mishandling og tilknytningsforstyrrelser, indlæringsproblemer, problemløsningsevner, kammeratskabsrelationer, angst, PTSD, adfærdsproblemer (Harts, Bransard, Binggeli, & Davidson, 2002).

Traumatisk barndomsoplevelser er en af de få identificerede årsager til psykiske lidelser (Kerns, Newschaffer, & Berkowitz, 2015). I en række enkelt undersøgelser finder man en robust sammenhæng mellem psykologisk børnemishandling og senere psykiske forstyrrelser som

- **depression** (Kuo et al., 2011; Martins, Baes, de Carvalho Tofoli, Sandra Marcia, & Jurueña, 2014; Massing-Schaffer, Liu, Kraines, Choi, & Alloy, 2015; Schulz et al., 2017),
- **angst** (Banducci, Lejuez, Dougherty, & MacPherson, 2017; Kuo et al., 2011; Nanda, Reichert, Jones, & Flannery-Schroeder, 2016),
- **alkohol og/eller stofmisbrug** (Banducci et al., 2017; Moran, Vuchinich, & Hall, 2004; Rosenkranz, Muller, & Henderson, 2012),
- **Post Traumatisk belastningsreaktion, PTSD** (Burns, Jackson, & Harding, 2010; Gibb, Chelminski, & Zimmerman, 2007),
- **selvmordsovervejelser og selvmordsforsøg** (Christoffersen, 2010; Norman et al., 2012) og
- **selvskade** (Christoffersen, Möhl, DePanfilis, & Vammen, 2015).

I en nyere systematisk forskningsoversigt finder man overhyppighed af depressioner, angst selvmordsforsøg, misbrug samt risikofyldt seksuel adfærd (Norman et al., 2012). De fundne sammenhænge syntes at være robuste

3 Det internationale begreb "psychological maltreatment" (Binggeli, 2001) ser man tit oversat til dansk som "psykisk vold". I det følgende vil "psykisk vold" blive anvendt synonymt med "psykologisk mishandling" (Christoffersen, 2002). nogle steder kan man finde udtrykket følelsesmæssig mishandling ("emotional abuse"), men "psykologisk mishandling" indfanger bedre det kognitive, affektive, og mellem menneskelige relationer mellem barnet og den voksne omsorgsperson (Binggeli, 2001).

over for de lidt forskellige metoder, der er anvendt til måling af psykologisk mishandling.

Flere forskere fremhæver, at psykisk vold kan være ligeså ødelæggende for et barn som fysisk vold se fx (Schulz et al., 2017). De senere undersøgelser har bekræftet dette billede. Men effekterne af psykologisk mishandling er ikke tilstrækkeligt forstået, og der mangler stadig et svar på det spørgsmål, som i sin tid blev stillet af Binggeli og kolleger: Hvorfor er psykologisk mishandling en så stærk destruktiv kraft i børns liv og udvikling? (Binggeli, 2001). En af forklaringerne kan være, at psykologisk mishandling ofte forekommer sammen med andre former for mishandling, fx fysisk mishandling, seksuelle overgreb eller vanrøgt (Christoffersen, 2002), og at det virker forstærkende, når der er en ophobning af flere alvorlige belastninger.

Social støtte kan afbøde skaden af psykisk vold

Det alvorligste problem er, at barnet ikke kan bryde med den mishandlende forælder og undslippe det destruktive overherredømme uden store omkostninger. Det er derfor helt afgørende, om barnet er i stand til at få social støtte af en anden voksen uden for det destruktive netværk (se tabel 5). Social støtte er en relation, der får personen til at tro, at han/hun er elsket og værdsat. Relationen er karakteriseret ved empati, forståelse og respekt. Personen, der giver social støtte er villig til at lytte og give råd; samt hjælpe med praktiske problemer. Barnet bliver gennem relationen bekræftet i sit

værd. Kontakt med andre i tilsvarende situationer kan give denne sociale støtte (Joseph, Williams, & Yule, 1992).

Når forældrene ikke kan give social støtte, så viser denne danske barnomsundersøgelse, at der var en række andre personer i netværket, der kunne yde denne form for social støtte. Der var først og fremmest bedsteforældre (42 pct.), venner (41 pct.) og andre søskende (46 pct.), men det kunne også være venners forældre, lærere og pædagoger (Vammen & Christoffersen, 2013).

Social støtte fra en anden person kan give modstandskraft hos disse unge, der har været udsat for traumatiske livsbegivenheder (Christoffersen et al., 2015; Runtz & Schallow, 1997), og at det er antagelsen at social støtte fra venner kan mindske risikoen for, at konsekvenserne af psykologisk mishandling (Schury et al., 2017). På baggrund af disse undersøgelser anbefales det, at man medinddrager social støtte som en mulig virksom indsats. De langvarige ødelæggende virkninger af psykologisk børnemishandling understreger vigtigheden af at identificere børnemishandling tidligt og sætte ind med en effektiv indsats (Christoffersen et al., 2015; Karmsteen, 2016).

Lovende undersøgelsesresultater om ændret forældreadfærd

Kan forældrenes adfærd ændres? Dette spørgsmål blev belyst i en undersøgelse blandt kommunale sagsbehandlere, der arbejder med udsatte børn (Christoffersen, 2002). Det vil sige børn, der bor sammen med deres forældre, og som samtidig får en eller anden form for forebyggende støtte, der skal hjæl-

pe familien til at fungere bedre, så børnene ikke skal fjernes fra hjemmet. I to tredjedele af disse nystartede sager var det forældrene selv, der havde henvendt sig til socialkontoret for at få hjælp og støtte.

Analysen af sagsbehandlingernes besvarelser viste, at børn udsat for psykisk vold også havde større tendens til at være depressive, uheldige, socialt isolerede, fejlnære, have spiseforstyrrelser, selvmordstanker, koncentrations- og adfærdsproblemer samt et ønske om at komme væk hjemmefra.

I sagsbehandlingernes vurdering var det omkring en tredjedel af de udsatte børn, der blev udsat for forskellige grader af psykisk vold af deres forældre, og blandt dem var der fire gange flere end i gruppen som helhed, der havde overvejet eller forsøgt selvmord (Christoffersen, 2002).

Selv om vi her har at gøre med de tungeste børnesager, er det stadig et højt tal – særligt når man tager i betragtning, at der i hele gruppen også var børn, som sagsbehandlerne mistænkte blev udsat for lejlighedsvis vold, vanrøgt eller seksuelle overgreb. Selv når man tog højde for disse forhold, viste tallene stadig, at den psykiske vold – mere end de fysiske overgreb – kunne forbindes med en øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsforsøg.

Dette billede bekræftes af, at selvmordsrisikoen blandt børnene blev mindre, når forældrene efter et forløb med familierapi behandlede barnet bedre. Det tydede altså på, at barnet simpelthen fik det bedre af at blive talt pæner til af sine forældre, også selv om de øvrige vilkår i hjemmet ikke

blev forbedret (Christoffersen & Depanfilis, 2009).

Konklusion

Vi ved stadig ikke nok om følgerne af psykologisk mishandling og dets samspil med andre former for overgreb på børn. Men at det kan være en voldsom, ødelæggende kraft i et barns liv, hersker der ingen tvivl om.

Desværre er den måde, vi taler til vores børn på, omgærdet af den samme berøringsangst, som for et par generationer siden herskede omkring den måde, vi behandlede dem fysisk: En fast opdragelse eller et hidsigt temperament er familiens egen sag, og ingen skal blande sig i, hvor meget man skælder sit barn ud. Men fra forskningen ved vi nu, at den verbale lussing kan være lige så ødelæggende for et barns udvikling som den fysiske.

Bestemmelser i straffeloven om psykisk vold mod børn kan være et nødvendigt magtmiddel til at få stoppet misgerningen og hjulpet forældrene gennem familierapi. Ved mistanke om fysisk vold kan en grundig undersøgelse af en børnelæge løfte bevisbyrden. Ved mistanke om psykisk vold kunne man forestille sig en tilsvarende udredning og ekspertudtalelser fra en eller flere uafhængige børnepsykologer. Det er derfor på tide med et større fokus på den psykiske vold, der begås mod børn.

Bilag

Tabel 1. Screenings spørgsmål stillet sundhedsplejerske om 2-årige

1.	Barnet bliver i perioder holdt indespærret
2.	Barnet bliver truet med vold/tæv
3.	Barnet bliver truet med tab af kærlighed el. af vigtige relationer
4.	Barnet bliver tiltalt el. omtalt på en krænkende måde (ond/dum/grim/umulig/ et barn ingen kan lide)
5.	Forældre forholder sig i perioder direkte fjendtligt til barnets behov
6.	Barnet bliver i perioder aktivt ignoreret af forældrene. Vil ikke høre barnet/ikke tale til det
7.	Barnet bliver aktivt forhindret i samvær med andre børn og/eller voksne
8.	Barnet bliver passet af et stort antal skiftende eller tilfældige voksne
9.	Barnet bliver mest passet af ikke-voksne større søskende

Kilde: Else Christensen: Omsorgssvigt? (Christensen, 1992). Psykologisk mishandling (som også benævnes for psykisk vold) er i denne undersøgelse kaldet 'aktiv følelsesmæssig omsorgssvigt'.

Tabel 2. Screeningsspørgsmål om psykisk vold baseret på interview med 25-årige:

1.	Har dine forældre/stedforælder ydmyget dig ved nedværdigende tiltale (f.eks. ved at blive kaldt dum, doven og uduelig)?
2.	Har dine forældre/stedforælder ydmyget og nedværdiget dig offentligt?
3.	Er du blevet truet med at blive smidt ud hjemmefra af dine forældre/stedforælder?
4.	Er du blevet truet med voldelig afstraffelse (f.eks. tæv, pisk) af dine forældre/ stedforælder?
5.	Har dine forældre/stedforældre gennem deres adfærd vist, at du var uønsket, ikke elsket og værdiløs?
6.	Har dine forældre/stedforældre konstant kritiseret dig og udsat dig for mobning?

Kilde: I undersøgelsen baseret på interview med 25-årige (Christoffersen, Møhl et al. 2015) kræves en bekræftelse på mindst tre ud af de 6 spørgsmål om psykisk vold, fordi der i denne undersøgelse lægges vægt på at kunne opfange forældre eller omsorgspersoners systematiske mobning af børnene før man kan tale om psykologisk mishandling, derved kommer man i denne undersøgelse frem til, at det er 5,3 pct. af børn, der oplever dette i barndommen (Vammen, Christoffersen 2013).

Tabel 3. Psykisk vold baseret på 6 spørgsmål stillet til sagsbehandler om et barn i en børnesag.

Gruppe I

-
1. Forældre ydmyger barnet/den unge fx ved nedværdigende tiltale, ved omtale overfor andre eller ved offentlig ydmygelse af barnet/den unge?
 2. Bliver barnet/den unge truet med at blive smidt ud hjemmefra (evt. anbragt udenfor hjemmet)
 3. Bliver barnet/den unge truet med voldelige afstraffelse (fx tæv, pisk)
 4. Bliver barnet/den unge overhørt, når det beder om hjælp
 5. Ignoreres barnets ønsker om hjælp og trøst fx når det er bange
 6. Er forældrene generelt ude af stand til at vise omsorg for barnet/den unge
-

Kilde: psykologisk mishandling baseret på journaloptegnelser udfyldt af barnets sagsbehandler (Christoffersen, 2002; Christoffersen & DePanfilis, 2010).

Tabel 4. Psykisk vold baseret på 6 spørgsmål stillet til sagsbehandler om et barn i en børnesag.

Gruppe II

-
1. Forældre viser gennem deres adfærd at barnet/den unge er uønsket, ikke elsket og værdiløst?
 2. Barnet/den unge terroriseres fx ved isolation, "taler ikke til barnet"?
 3. De voksnes konsekvente mobning af barnet/den unge eller konstant kritik af barnet/den unges adfærd?
 4. Forældre fremkommer med trusler om at skade barnet/den unge eller overlade det til andre?
 5. Bliver barnet placeret i farlige situationer?
 6. Bliver barnet/den unge isoleret, hvor barnet/den unge forbydes kontakt med jævnaldrende fx ved urimelige restriktioner på barnet/den unges bevægelsesfrihed?
-

Kilde: psykologisk mishandling baseret på journaloptegnelser udfyldt af barnets sagsbehandler (Christoffersen, 2002; Christoffersen & DePanfilis, 2010).

Tabel 5. Screeningsspørgsmål om social støtte stillet til 25-årige.

-
1. En social relation, der får personen til at tro at han/hun er elsket og værdsat.
 2. Relationen er karakteriseret ved empati, forståelse og respekt.
 3. Hjælp med praktiske problemer
 4. Villig til at lytte og give råd
 5. Bekræfte barnets værd
 6. Vise barnet respect
 7. Kontakt med andre i tilsvarende situationer
-

Kilde: Crisis Support Scale (CSS) (Joseph, Williams, & Yule, 1992)

References

- Banducci, A. N., Lejuez, C., Dougherty, L. R., & MacPherson, L. (2017). A prospective examination of the relations between emotional abuse and anxiety: Moderation by distress tolerance. *Prevention Science*, 18(1), 20-30.
- Binggeli, N. J. (2001). In Hart S. N., Brassard M. R. (Eds.), *Psychological maltreatment of children*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Binggeli, N. J., Hart, S. N., & Brassard, M. R. (2001). In Hart S. N., Brassard M. R. (Eds.), *Psychological maltreatment of children*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Brassard, M. R., Hart, S., & Hardy, D. B. (1991). Psychological and emotional abuse of children. In R. T. Ammerman, & M. Hersen (Eds.), (pp. 255-270). New York: Plenum Press.
- Brassard, M. R., & Hart, S. (2000). What is psychological maltreatment? In H. Dubowitz, & D. DePanfilis (Eds.), (pp. 23-27). Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
- Burns, E. E., Jackson, J. L., & Harding, H. G. (2010). Child maltreatment, emotion regulation, and posttraumatic stress: The impact of emotional abuse. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 19(8), 801-819.
- Busby, D. M. (1991). Violence in the family. In S. J. Bahr (Ed.), (pp. 335-385). Lexington, Mass.: Lexington Books.
- Cawson, P. (2002). In National Society for the Prevention of Cruelty to Children. (Ed.), *Child maltreatment in the family: The experience of a national sample of young people*. National Society for the Prevention of Cruelty to Children.
- Cawson, P., Wattam, C., Brooker, S., & Kelly, G. (2000). In Wattam C., Brooker S. and National Society for the Prevention of Cruelty to Children. (Eds.), *Child maltreatment in the united kingdom: A study of the prevalence of child abuse and neglect*. National Society for the Prevention of Cruelty to Children.
- Christensen, E. (1992). *Omsorgssvigt: En rapport om de 0-3-årige baseret på sundhedsplejerskers viden SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd*.
- Christoffersen, M. N., & DePanfilis, D. (2009). Prevention of child abuse and neglect and improvements in child development. *Child Abuse Review: Journal of the British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect*, 18(1), 24-40.
- Christoffersen, M. N. (2002). *Social støtte til børn. En undersøgelse af børn, der modtog forebyggende hjælp i henhold til serviceloven for første gang i 1998. 5. delrapport i evaluering af den forebyggende indsats over for børn og unge*. København: Socialforskningsinstituttet.
- Christoffersen, M. N. (2010). *Børnemishandling i hjemmet*. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
- Christoffersen, M. N., & DePanfilis, D. (2010). Psychological maltreatment and adolescents' suicidal behavior: A nationwide sample of 1,055 children at risk. *Journal of Child & Adolescent Trauma*, 3(2), 109-124.
- Christoffersen, M. N., Möhl, B., DePanfilis, D., & Vammen, K. S. (2015). Non-suicidal self-injury: Does social support make a difference? an epidemiological investigation of a danish national sample. *Child Abuse & Neglect*, 44(0), 106-116.
- Egeland, B., & Erickson, M. F. (1987). Psychologically unavailable caregiving. In M. R. Brassard, R. Germain & S. N. Hart (Eds.), (pp. 110-120). New York: Pergamon Press.
- Erickson, M. F., & Egeland, B. (2002). Child neglect. In J. E. B. Myers, L. Berliner, J. Briere, C. T. Hendrix & C. R. Jenny T. (Eds.), (pp. 3-20). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Erickson, M. F., & Egeland, B. (1987). A developmental view of the psychological consequences of maltreatment. *School Psychology Review*, 16(2), 156-168.
- Garbarino, J., Guttman, E., & Seeley, J. W. (1987). In Guttman E., Seeley J. W. (Eds.), *The psychologically battered child: Strategies for identification, assessment and intervention*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Gibb, B. E., Chelminski, I., & Zimmerman, M. (2007). Childhood emotional, physical, and sexual abuse, and diagnoses of depressive and anxiety disorders in adult psychiatric outpatients. *Depression & Anxiety* (1091-4269), 24(4), 256-263.
- Gross, A. B., & Keller, H. R. (1992). Long-term consequences of childhood physical and psychological maltreatment. *Aggressive Behavior*, 18(3), 171-185.
- Hamerman, S., & Ludwig, S. (2000). Emotional abuse and neglect. In R. M. Reece (Ed.),

- (pp. 201-210). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Harts, S. N., Brassard, M. R., Binggeli, N. J., & Davidson, H. A. (2002). Psychological maltreatment. In J. E. B. Myers, L. Berliner, J. Briere, C. T. Hendrix, C. Jenny & T. Reid (Eds.), (pp. 79-103). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Joseph, S., Williams, R., & Yule, W. (1992). Crisis support, attributional style, coping style, and post-traumatic symptoms. *Personality and Individual Differences*, 13(11), 1249-1251.
- Kempe, C. H., Silverman, F. N., Steele, B. F., Droegemueller, W., & Silver, H. K. (1962). The battered child syndrome. *Journal of the American Medical Association*, 181(1), 17-24.
- Kerns, C. M., Newschaffer, C. J., & Berkowitz, S. J. (2015). Traumatic childhood events and autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 45(11), 3475-3486.
- King, W. K., Kiesel, E. L., & Simon, H. K. (2006). Child abuse fatalities: Are we missing opportunities for intervention? *Pediatric Emergency Care*, 22(4), 211-214.
- Kolko, D. J. (2002). Child physical abuse. In J. E. B. Myers, L. Berliner, J. Briere, C. T. Hendrix, C. Jenny & T. Reid (Eds.), (pp. 21-54). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Kuo, J. R., Goldin, P. R., Werner, K., Heimberg, R. G., & Gross, J. J. (2011). Childhood trauma and current psychological functioning in adults with social anxiety disorder. *Journal of Anxiety Disorders*, 25(4), 467-473.
- Martins, C. M. S., Baes, C. V. W., de Carvalho Tofoli, Sandra Marcia, & Jurueña, M. F. (2014). Emotional abuse in childhood is a differential factor for the development of depression in adults. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 202(11), 774-782.
- Massing-Schaffer, M., Liu, R. T., Kraines, M. A., Choi, J. Y., & Alloy, L. B. (2015). *Elucidating the relation between childhood emotional abuse and depressive symptoms in adulthood: The mediating role of maladaptive interpersonal processes* doi:<https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.09.045>
- Moran, P. B., Vuchinich, S., & Hall, N. K. (2004). Associations between types of maltreatment and substance use during adolescence. *Child Abuse & Neglect*, 28(5), 565-574.
- Mullen, P. E., Martin, J. L., Anderson, J. C., Romans, S. E., & Herbison, G. P. (1996). The long-term impact of the physical, emotional, and sexual abuse of children: A community study. *Child Abuse & Neglect*, 20(1), 7-21.
- Myers, J. E. B., Berliner, L., Briere, J., Hendrix, C. T., Jenny, C., & Reid, T. A. (2002). In Myers J. E. B., American Professional Society on the Abuse of Children. (Eds.), *The APSAC handbook on child maltreatment*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nanda, M. M., Reichert, E., Jones, U. J., & Flannery-Schroeder, E. (2016). Childhood maltreatment and symptoms of social anxiety: Exploring the role of emotional abuse, neglect, and cumulative trauma. *Journal of Child & Adolescent Trauma*, 9(3), 201-207.
- Newberger, E. (1972). Myth of the battered child syndrome – a compassionate medical view of the protection of children.
- Norman, R. E., Byambaa, M., De, R., Butchart, A., Scott, J., & Vos, T. (2012). The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: A systematic review and meta-analysis. *PLoS Medicine*, 9(11), e1001349.
- Ottosen, M H; Frederiksen, S; & Henze-Pedersen, Sofie: Psykisk vold mod børn i hjemmet – et vidensgrundlag. VIVE, 2020.
- Ravichandiran, N., Schuh, S., Bejuk, M., Al-Harthi, N., Shouldice, M., Au, H., et al. (2010). Delayed identification of pediatric abuse-related fractures. *Pediatrics*, 125(1), 60-66.
- Rosenkranz, S. E., Muller, R. T., & Henderson, J. L. (2012). Psychological maltreatment in relation to substance use problem severity among youth. *Child Abuse & Neglect*, 36(5), 438-448.
- Runtz, M. G., & Schallow, J. R. (1997). Social support and coping strategies as mediators of adult adjustment following childhood maltreatment. *Child Abuse & Neglect*, 21(2), 211-226.
- Schulz, P., Beblo, T., Ribbert, H., Kater, L., Spannhorst, S., Driessen, M., et al. (2017). *How is childhood emotional abuse related to major depression in adulthood? the role of personality and emotion acceptance* doi:<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.07.022>
- Schury, K., Zimmermann, J., Umlauft, M., Hulbert, A., Guendel, H., Ziegenhain, U., et al. (2017). Childhood maltreatment,

postnatal distress and the protective role of social support. *Child Abuse & Neglect*, 67, 228-239.

Vammen, K. S., & Christoffersen, M. N. (2013). *Unge selvskade og spiseforstyrrelse: Kan social støtte gøre en forskel?* SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.